

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 23:35:00

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Icaro Ulises Constenla Carrillo
Edad : 54a 11m 17d
Dirección : Calle San Jorge 2240

Rut : 9.813.790-4
Fecha Nacto: 12/02/1971
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2303696
Sexo : Masculino
Teléfono : 921819195

N° Epicrisis
470187

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 04/01/2026 08:33

Días Estadía: 25

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 29/01/2026 23:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR SU: 04/01/2026
FI UPC: 06/01/2026
FI UTIM 27/01/2026

ANTECEDENTES

Mórbidos: Asma severo, EPOC tabáquico activo, policonsumo suspendido, temblor esencial

Hospitalizaciones recientes:

- . Sept 2025: EPOC manejado con VMNI
- . Junio 2025: EPOC descompensado con buena respuesta a VMNI
- . Abril 2025: LCFA descompensado con buena respuesta a BD y oxígeno
- . 2023: LCFA descompensado, manejo con IOT

Medicamentos: Spiriva 2 inhalaciones noche a permanencia, Fluticasona/salmeterol 250/50 2 inhalaciones cada 12 horas a permanencia, Salbutamol 2 inhalaciones sos

Quirúrgicos: (-)

Alergias: (-)

Hábitos: TBQ (Activo. Actualmente 10 cigarros/día, IPA 40) OH (+, 2 veces al mes) Drogas THC (suspendido)

Inmunizaciones: COVID (+), FLU (+)

Social: Pensionado por EPOC. Independiente para las actividades instrumentales de la vida diaria. Vive solo. CF I

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes de asma severa + EPOC tabáquico activo presenta cuadro de 2 horas de evolución caracterizado por disnea súbita rápidamente progresiva, asociado a tos con expectoración, por lo que consulta inicialmente en APS, en donde describen clinic obstructiva y aumento de requerimientos de oxígeno a pesar de inicio de corticoterapia y broncodilatación. Es trasladado al servicio de urgencias de CASR e ingresa directamente al reanimador en regulares condiciones generales, hemodinámicamente estable. En la evaluación primaria destaca vía aérea permeable sin estridor, mala mecánica respiratoria, vigil, cooperador. Al examen físico se ausculta murmullo pulmonar globalmente disminuido, ruidos cardiacos apagados. De los exámenes de laboratorio de ingreso destaca acidosis respiratoria severa con pCO2 en 67 mmHg, panel viral negativo, Rx de tórax con signos de hiperinsuflación. En el servicio de urgencias se inicia VMNI precoz, corticoides + sulfato de magnesio. Evolucionan con hemodinamia inestable, llene capilar 4 seg, PAM 55, por lo que se administra volumen y se inicia BIC NAD. Persiste taquipneico, con mala mecánica ventilatoria por lo que se decide intubar y conectar a VMI. Ingresan

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 23:35

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 23:35:00

Página 2 de 4

a UPC para continuar estudio y manejo.

LABORATORIO DE INGRESO:

04/01: Hto 47, Hb 15.6, GB 6820, Pla_q 396.000, INR 1.03, TTPA 29.6, PCR 1.8, GSV pH 7.1 pCO₂ 67.7 HCO₃ 24.8, crea 0.77, BUN 16.6, glicemia 111, lactato 1.4, BT 0.71, BD 0.19, FA 79. GGT 50, GOT 63, GPT 28, Ca 8.8

MICROBIOLOGÍA DE INGRESO:

04/01 Panel viral respiratorio (-)

IMÁGENES DE INGRESO:

06/01 AngioTAC de Tórax: Estudio técnicamente limitado por las condiciones antes descritas. En este contexto no se observan signos de TEP hasta territorio segmentario proximal. La arteria del LSD no es evaluable.

Signos de bronquiolitis en LM.

05/01 Rx de Tórax: Signos de hiperinsuflación

DIAGNÓSTICOS INGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda severa

· Status asmático

2. Antecedentes: Asma, EPOC

EVOLUCIÓN DURANTE UPC

Ingresa a UPC el 05/01 por insuficiencia respiratoria catastrófica. AngioTAC de ingreso descartó TEP central, evidenciando signos de bronquiolitis. Evolucionó con patrón obstructivo severo y difícil manejo ventilatorio requiriendo sedación profunda, sulfato de magnesio, broncodilatación continua, bic de aminofilina (sólo pr 24 hrs por quiebre de stock) y bloqueo neuromuscular (BNM) desde su ingreso hasta el día 20/01. Como descompensante se obtiene CAET SAMR, que se maneja por 5 días con vancomicina, siempre sin fiebre y con parámetros inflamatorios bajos. Por persistencia de crisis obstructiva grave se decide pulso de MTP (250 mg por 3 días). Posteriormente con lenta recuperación, menos hiperreactivo, se obtiene nuevo CAET esta vez positivo a PSAE MS que se maneja con ceftazidima. Sin otras disfunciones de órganos. El 20/01 se decide suspensión de BNM y en días siguientes se suspende progresivamente sedación hasta extubación el día 23/1. Se apoya con CNAF y VNI hasta el día 26/1, cumpliendo ya 24 hrs sólo con naricera con oxígeno suplementario a su traslado. Con disfonía marcada y disfagia FILS 4 en rehabilitación fonoaudiológica

MICROBIOLOGÍA RELEVANTE

27/01 HC I y II (-) Cultivo punta de catéter

17/01 CAET (+) P. Aeruginosa (MS)

06/01 CAET (+) S. Aureus R a Clindamicina, Cloxacilina, Eritromicina UC (-)

EVOLUCIÓN

Hemodinamia: NAD dosis bajas al ingreso. Evolución favorable suspende DVA precozmente. Sin conflicto posterior.

Ventilatorio: Ingresa a UPC el 05/01 por insuficiencia respiratoria catastrófica. AngioTAC de ingreso descartó TEP central, evidenciando signos de bronquiolitis. Evolucionó con patrón obstructivo severo y difícil manejo ventilatorio, requiriendo sedación profunda, sulfato de magnesio, broncodilatación continua, bic de aminofilina (sólo pr 24 hrs por quiebre de stock) y bloqueo neuromuscular (BNM) desde su ingreso hasta el día 20/01. Por persistencia de crisis obstructiva grave se decide pulso de metilprednisolona (250 mg por 3 días). Posteriormente con lenta recuperación. Logra extubación el día 23/01 con salida a VNI. Con weaning consolidado se traslada a UTIM. Mantiene esquema de broncodilatadores, a espera de traer aquellos de uso crónico, titulando a la baja prednisona.

ORL: Se habría sospechado miasis en UPC, sin embargo, con nasofibroscofia realizada que no evidencia larvas. Sugieren TAC CPN solicitada, pendiente realizar durante estadía. Con disfonía desde extubación se solicitó reevaluación por ORL, pendiente durante estadía.

Rehabilitación: Seguimiento por fonoaudiología logrando hasta alimentación mixta con régimen licuado, asistido y líquidos espesados, sin lograr desempeño suficiente para retiro de sonda. Con importante miopatía secundaria a Bloqueo neuromuscular prolongado y corticoides sistémicos.

Infeccioso:

- Al ingreso se obtiene CAET SAMR, que se maneja por 5 días con vancomicina.

- 17/01 traqueobronquitis por PSAE MS que se maneja con ceftazidima.

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 23:35

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 23:35:00

Página 3 de 4

Sin interurrencias posteriores o proceso infeccioso activo.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

- 1) Crítico crónico
 - 2) Insuficiencia respiratoria aguda en resolución
- Crisis asma grave
- Resueltos:
- Traqueobronquitis por SAMR tratada
 - Traqueobronquitis por PSAE MS tratada
- Antecedentes: Tabaquismo activo / Policonsumo

Diagnóstico de Egreso

ASMA -

Condición de Egreso Alta Derivado al HLF Dra. Eloísa Díaz Insunza

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, mantiene requerimientos de oxígeno de 1lt logrando metas de saturación y con adecuada mecánica. Regular desempeño oral por lo que mantiene SNG para lograr complementación de aportes.

Plan Post Alta

INDICACIONES A SU TRASLADO

Reposo relativo, activar por KNT según tolerancia.

NE Fresubin HP a 40 ml/h + Agua libre a 20 ml/h por SNG + Complementario régimen licuado + compota de fruta almuerzo y cena, asistido a 90° vía oral

HGT AM + cada 8 horas

KNT respiratoria + motora (PEF cada 12 horas)

O2 para SatO2 >92%.

Invasivos: VVP, SNG, CUP

Alergias: (-)

Bromuro de Ipratropio/Fenoterol 2 puff cada 4 horas con AEC (intercalar)

Salbutamol 2 puff cada 4 horas con AEC (intercalar)

Budesonida 200 mcg, 3 puff cada 12 horas con AEC

Spiolto 2 inhalaciones al día

Prednisona 30 mg cada 24 horas SNG

Quetiapina 25 mg en las noches por SNG

Cotrimoxazol forte 1 comprimido trisemanal SNG (L-M-V)

Omeprazol 20 mg cada 24 horas EV

PEG 15 g (disolver en 200 cc de agua) cada 24 horas SNG

Enoxaparina 40 mg cada 24 horas SC

SOS:

Metamizol 1 g EV SOS en caso de dolor

Haloperidol 2.5 mg EV SOS en caso de agitación

PLANES:

- Rehabilitación motora
- Rehabilitación fonoaudiológica
- Evaluación por ORL por sospecha de paresia cordal

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 23:35

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 23:35:00

Página 4 de 4

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Matías Sebastián Larenas Vivanco
Médico Tratante (Staff)